

AC03 – ENSAIO CONCEITUAL

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, observa-se um aumento significativo de transtornos mentais, cenário associado ao ritmo acelerado da vida urbana, ao uso excessivo de tecnologias e à hiperconectividade. Nesse contexto, a Psicologia Ambiental defende que o ambiente construído não atua apenas como um pano de fundo passivo, mas como um agente ativo capaz de influenciar comportamentos, processos afetivos e o bem-estar psicofisiológico. Contudo, nota-se que muitos espaços destinados ao cuidado em saúde mental ainda são regidos por lógicas puramente funcionais e institucionais, o que frequentemente negligencia o impacto dos atributos espaciais na subjetividade e na qualidade de vida dos usuários.

A lacuna explorada neste estudo reside na necessidade de aprofundar a compreensão sobre como o espaço arquitetônico, fundamentado nos princípios do design de suporte e no potencial dos ambientes restauradores, pode atuar de forma terapêutica na mitigação do estresse e na recuperação da fadiga atencional. Assim, o propósito deste trabalho consiste no desenvolvimento de um Centro de Saúde Mental e Práticas Integrativas. A proposta visa utilizar a arquitetura como ferramenta de cuidado, incorporando elementos naturais e estratégias multissensoriais para promover a restauração de recursos pessoais e o acolhimento integral do indivíduo.

JUSTIFICATIVA

A relevância social deste trabalho fundamenta-se na necessidade urgente de enfrentar o esgotamento psicofisiológico característico dos contextos urbanos contemporâneos. Conforme aponta a Organização Mundial da Saúde, o ritmo acelerado das cidades e a hiperconectividade têm impulsionado o que se identifica como uma "epidemia de transtornos mentais". O aumento de patologias como a ansiedade e a depressão é intensificado por um estilo de vida marcado pela dependência tecnológica e pelo ritmo exaurido das metrópoles, o que demanda espaços capazes de oferecer reconexão e alívio

psicofisiológico. Nesse cenário, a arquitetura assume um papel vital como agente ativo de cuidado, superando a visão tradicional do edifício como um mero invólucro funcional ou pano de fundo passivo onde a vida apenas se desenrola.

No campo técnico-científico, o trabalho propõe um aprofundamento teórico sobre o ambiente construído como mediador clínico, testando a hipótese de que estratégias de Psicologia Ambiental e sensorialidade podem mitigar o estresse e recuperar a fadiga atencional dirigida. A pesquisa aprofunda o debate entre vitalidade e passividade, buscando superar o uso de "simulacros de natureza" — elementos artificiais que apenas imitam o natural sem permitir agência real — em favor de espaços onde a "vida confronta a vida" por meio do movimento e do engajamento do usuário.

Ao explorar o conceito de entre-lugar, a investigação foca no potencial dos espaços de transição como zonas de mediação que permitem uma percepção gradual do ambiente, facilitando o acolhimento e o sentimento de pertencimento. Segundo Simonsen, Brown e Reavey (2024), o design não deve ser um simulacro controlado, mas um facilitador de encontros significativos e autonomia. Assim, o trabalho justifica-se por consolidar subsídios teóricos que validam o espaço como ferramenta essencial de responsabilidade social e cuidado integral, diminuindo o hiato entre a estética arquitetônica e a eficácia terapêutica.

OBJETIVO

Propor o anteprojeto de um Centro de Saúde Mental e Práticas Integrativas fundamentado em diretrizes de ambientes restauradores e da experiência multissensorial para potencializar a restauração psicofisiológica de indivíduos em contextos urbanos exauridos.

- Aplicar princípios da psicologia ambiental por meio da incorporação de elementos naturais e da organização espacial, visando à redução do estresse e à restauração da atenção.
- Aplicar estratégias multissensoriais (táteis, visuais, sonoras e olfativas) que qualifiquem a experiência do usuário e reforcem a sensação de acolhimento.
- Estruturar o conjunto a partir de gradientes espaciais e áreas de transição, promovendo diferentes níveis de privacidade, permanência e interação.
- Integrar soluções de conforto ambiental, sustentabilidade e materialidade natural como componentes da linguagem arquitetônica.

RECORTE DA REVISÃO DE LITERATURA

A literatura revisada revela que a relação entre ambiente construído e saúde mental é um campo interdisciplinar consolidado pela Psicologia Ambiental e pelo Design Baseado em Evidências (EBD). As abordagens identificadas organizam-se, primordialmente, em torno da Teoria do Design de Suporte, que prioriza o controle pessoal e o suporte social, e das teorias de Ambientes Restauradores, como a Teoria da Restauração da Atenção (ART) e a Teoria Psicoevolucionista (PET), que investigam como estímulos ambientais mitigam o estresse e a fadiga mental.

No cenário brasileiro, observa-se uma convergência com o conceito de ambiência da Política Nacional de Humanização, que defende o espaço como ferramenta facilitadora do processo de trabalho e de encontros. Entretanto, persistem tensões significativas entre as lógicas puramente funcionais das instituições tradicionais e a necessidade de espaços sensíveis à subjetividade do usuário. A literatura aponta ainda um hiato crítico: embora o poder restaurador da natureza seja amplamente documentado, há uma carência de estudos sobre como atributos arquitetônicos específicos em ambientes urbanos construídos podem ativamente promover a restauração.

Este trabalho situa-se na fronteira dessa discussão, propondo a "Vitalidade" como resposta ao estigma do confinamento. A pesquisa aprofunda o debate ao propor a superação de "simulacros de natureza" em favor de espaços que promovam vitalidade real por meio do engajamento do sujeito. Assim, o tema insere-se no campo ao investigar como o conceito de entre-lugar e a experiência multissensorial podem estruturar ambientes que não apenas abriguem o tratamento, mas que atuem como instrumentos clínicos de restauração em contextos urbanos exauridos. Ao integrar a neuroarquitetura e a arquitetura multissensorial, a pesquisa testa a hipótese de que a cura exige agência e movimento.

CONCEITOS ESTRUTURANTES DA PROPOSTA

Para fundamentar a concepção de um espaço voltado ao cuidado integral, o referencial teórico desta proposta estrutura-se a partir de três conceitos estruturantes que visam compreender o ambiente construído não apenas como abrigo funcional, mas como um mediador clínico capaz de promover a restauração psicofisiológica. Esses pilares buscam responder às necessidades dos usuários, integrando a percepção humana, a sensorialidade e a organização espacial ao desenho arquitetônico.

- **Psicologia Ambiental:** É o campo científico dedicado à compreensão das inter-relações entre as pessoas e os ambientes que habitam, considerando aspectos físicos, sociais, históricos e culturais. Sob essa ótica, o espaço deixa de ser um pano de fundo passivo para tornar-se um agente ativo, capaz de encorajar ou limitar certas manifestações psíquicas, influenciando diretamente o bem-estar e a qualidade de vida. A disciplina defende que lugares e pessoas se tecem mutuamente de modo indissociável, o que justifica o uso do Design Baseado em Evidências (EBD) para planejar ambientes que mitiguem o estresse e potencializem a saúde. Assim, a pesquisa busca entender como atributos espaciais específicos fortalecem a identidade do indivíduo e sua relação com o meio.
- **Arquitetura Multissensorial:** Compreende o espaço como uma experiência total e incorporada, percebida não apenas pela visão, mas por todos os sentidos — tato, olfato, audição e movimento corporal. Conforme Juhani Pallasmaa, a arquitetura deve ser a "arte da reconciliação entre nós mesmos e o mundo", mediada pelos sentidos. Nessa abordagem, componentes como a luz deixam de ser meros recursos técnicos para se tornarem aparelhos perceptivo-biológicos fundamentais na regulação circadiana e emocional. Além disso, a arquitetura multissensorial busca a vitalidade, superando "simulacros de natureza" em favor de ambientes onde a "vida confronta a vida", permitindo que o usuário se sinta integrado por meio de estímulos fascinantes e materiais naturais. Estratégias como a redução de ruídos por superfícies absorventes e a estimulação olfativa positiva são ferramentas vitais para a regulação emocional e o acolhimento.
- **Entre-lugar:** Baseado no conceito de in-between proposto por Aldo van Eyck, define a arquitetura como uma zona de transição capaz de reconciliar polaridades, como o interior privado e o exterior público. Esse conceito foca no potencial dos espaços de mediação — simbolizados pela soleira (doorstep) — para promover o encontro e o sentimento de pertencimento. Segundo a perspectiva de Yi-Fu Tuan, o "espaço" abstrato transforma-se em "lugar" significativo à medida que o indivíduo o vivencia, dota de valor afetivo e nele imprime suas marcas. No projeto de saúde, o entre-lugar manifesta-se através de gradientes espaciais e áreas de transição que permitem uma percepção gradual do ambiente, oferecendo segurança e autonomia ao usuário enquanto este navega entre diferentes níveis de privacidade e interação social.

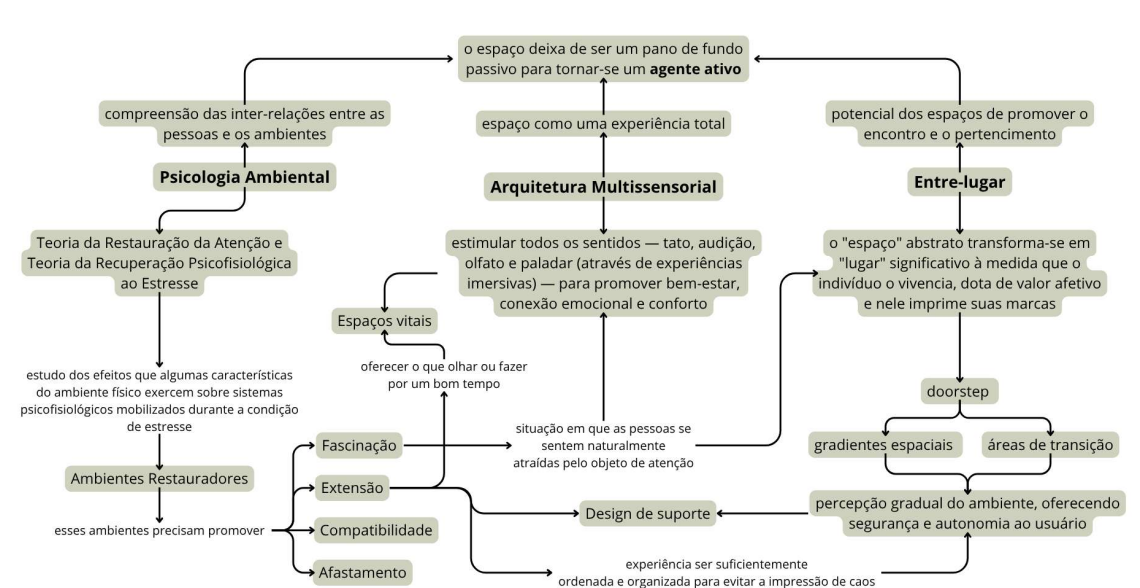
Esses pilares permitem antever as formas de interação entre pessoas e ambientes, orientando a futura criação de espaços que favoreçam o acolhimento e a restauração dos recursos pessoais exauridos.

SÍNTESE INTERPRETATIVA

A integração entre os conceitos estruturantes fundamenta-se na compreensão do ambiente construído como um agente ativo de cuidado, onde a Psicologia Ambiental fornece a base científica ao demonstrar que lugares e pessoas se influenciam mutuamente de modo indissociável. Essa relação se materializa através da Arquitetura Multissensorial, que utiliza luz, texturas e sons para mediar a "reconciliação entre nós mesmos e o mundo". Ao engajar todos os sentidos, essa abordagem combate a apatia da depressão e mitiga o estresse por meio de estímulos inerentemente fascinantes que permitem o repouso da atenção dirigida fadigada.

O Entre-lugar complementa essa dinâmica ao atuar como uma zona de mediação. Ao estruturar espaços de transição, a arquitetura permite uma percepção gradual do entorno, oferecendo o senso de controle necessário para reduzir a ansiedade e o estado de alerta constante. Juntos, esses conceitos promovem a vitalidade, superando a passividade dos espaços institucionais. A harmonia entre o acolhimento sensorial e a clareza espacial possibilita a restauração psicofisiológica, ajudando o indivíduo a recompor recursos pessoais exauridos pelo ritmo urbano acelerado.

DIAGRAMA CONCEITUAL



REFERÊNCIAS

- AL KHATIB, M.; SAMARA, M.; NDIAYE, A. Impact of biophilic design on patient and staff outcomes in healthcare facilities. *Frontiers in Built Environment*, v. 10, 2024.**
- ALVES, Lucas Silva; CELASCHI, Carolina Menzl. A neuroarquitetura e a investigação do caráter terapêutico do espaço. *Oculum Ensaio*, v. 21, e245412, 2023.**
- FORNEFELD, D. et al. Evaluation of the therapeutic relevance of architectural aspects in child and adolescent psychiatry – a pilot study. *BMC Psychiatry*, v. 24, n. 819, 2024.**
- HAIDT, Jonathan. A geração ansiosa: como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Tradução: Lígia Azevedo. São Paulo: Companhia das Letras, 2024.**
- JANSEN, Lucas. Resenha de A geração ansiosa: como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. *Texto Livre*, Belo Horizonte, v. 19, e64400, 2026.**
- MEDEIROS, Luciana de. Arquitetura e humanização em saúde: aproximando saberes e perspectivas. *Gestão & Tecnologia de Projetos*, São Carlos, v. 19, n. 1, p. 52-67, 2024.**
- MENDES, Ludmila Cardoso Fagundes; SOUZA, Roberta Vieira Gonçalves de. Indicadores que interpretam fatores humanos na arquitetura hospitalar. *Gestão & Tecnologia de Projetos*, São Carlos, v. 19, n. 1, p. 126-147, 2024.**
- MESQUITA, Thaiane Rodrigues; LEITE, Jovina Cristina Soares; BARROS, Brenda Lícia Xavier Pantoja. Geração Z e dependência tecnológica: evidências psicológicas sobre prejuízos à saúde mental. *Revista DELOS*, Curitiba, v. 18, n. 74, p. 01-21, 2025.**
- MONIZ, Edna; AFONSO, Rosa Marina. Depressão e ansiedade em cuidadores pertencentes à geração sandwich. *Revista Psicologia, Saúde & Doenças*, v. 22, n. 3, p. 1079-1090, 2021.**
- PRAGATI, S. et al. Efeitos do ambiente construído na recuperação da saúde mental das pessoas – revisão da literatura. *Frontiers in Engineering and Built Environment*, v. 2, n. 1, p. 34-42, 2022.**
- SACK, O. ‘A symbol with what architecture means as such and should accomplish’. *ARENA Journal of Architectural Research*, v. 9, n. 1, p. 4, 2024.**

SILVEIRA, Bettieli Barboza da; **FELIPPE**, Máira Longhinotti (Org.). **Ambientes restauradores: conceitos e pesquisas em contextos de saúde**. Florianópolis: UFSC, 2019.

SILVEIRA, Bettieli Barboza da; **KUHNEN**, Arianne. **Psicologia ambiental e saúde na relação pessoa-ambiente: uma revisão sistemática**. *Psi Unisc*, v. 3, n. 1, p. 89-105, 2019.

SILVEIRA, Bettieli Barboza da; **KUHNEN**, Arianne; **FELIPPE**, Máira Longhinotti. **Retratos de um hospital de custódia: os espaços verdes e sua relação com a restauração psicofisiológica do estresse**. *Pesquisas e Práticas Psicossociais*, São João del Rei, v. 13, n. 4, 2018.

SIMONSEN, Thorben Peter Høj; **BROWN**, Steven D.; **REAVEY**, Paula. **Vitality and nature in psychiatric spaces: Challenges and perspectives for healing architecture in the design of mental health inpatient environments**. *Health & Place*, 2024.